



COLLANA EDITORIALE

POLICY BRIEF 01 • 2026

Scuola ed epilessia

Dall'emergenza alla piena inclusione

FORMAZIONE • PROTOCOLLI • CONTINUITÀ TERAPEUTICA

FONDAZIONE BOSCACCI ETS

POLICY BRIEF 01 • 2026

Scuola ed Epilessia

Dall'emergenza alla piena inclusione

Formazione, protocolli, continuità terapeutica e responsabilità condivisa nella scuola italiana

Perché questo Policy Brief

Il documento nasce dal confronto istituzionale dedicato a "Scuola ed Epilessia", svoltosi in Regione Lombardia nel giugno 2025. L'obiettivo è trasformare le criticità emerse dal confronto tra istituzioni, clinici, famiglie e stakeholder in un'agenda operativa per rendere la frequenza scolastica realmente sicura, inclusiva e uniforme sul territorio nazionale.

Fondazione Boscacci ETS

Salute • Politiche pubbliche • Inclusione

EXECUTIVE SUMMARY

Una scuola preparata è una scuola inclusiva

L'epilessia è una condizione neurologica che può accompagnare bambini e adolescenti durante tutto il percorso scolastico. Nella vita quotidiana, tuttavia, il principale ostacolo non è sempre la malattia in sé: spesso sono l'assenza di procedure condivise, la paura dell'emergenza, la disomogeneità delle informazioni e lo stigma a generare esclusione o limitazioni non necessarie.

Il confronto promosso in Regione Lombardia ha evidenziato quattro bisogni ricorrenti: maggiore formazione del personale scolastico; informazioni cliniche chiare e tempestive fornite dalla famiglia; procedure semplici per la gestione della crisi e dell'eventuale terapia di emergenza; coordinamento stabile tra scuola, famiglia, servizi sanitari e istituzioni.

La tesi centrale

L'inclusione scolastica degli studenti con epilessia non può dipendere dalla buona volontà dei singoli istituti. Occorre un modello nazionale essenziale, applicabile e proporzionato, che definisca responsabilità, formazione minima, flussi informativi e protocolli operativi.

Cinque priorità

- Formazione essenziale e periodica del personale scolastico.
- Piano individuale condiviso tra famiglia, scuola e curanti.
- Protocollo nazionale per crisi epilettiche e farmaci di emergenza.
- Tutela della privacy senza ostacolare la sicurezza dello studente.
- Monitoraggio dell'inclusione e riduzione dello stigma.

01 • IL PROBLEMA

Quando l'incertezza diventa una barriera

La scuola è uno dei luoghi in cui la gestione dell'epilessia mette maggiormente alla prova la capacità del sistema di integrare salute e inclusione. Una crisi epilettica può essere spettacolare o discreta, breve o prolungata; non ogni episodio richiede un intervento farmacologico, ma ogni istituto deve sapere cosa fare, chi chiamare e quali informazioni utilizzare.

In assenza di indicazioni uniformi, le famiglie possono essere spinte a negoziare caso per caso condizioni di frequenza, gite, attività sportive o somministrazione di farmaci. Questa variabilità alimenta disuguaglianze territoriali e può tradursi in assenze evitabili, ansia per i caregiver e restrizioni sproporzionate per lo studente.

Dal comunicato post-conferenza

Il confronto istituzionale ha richiamato la necessità di colmare le difficoltà che bambini e adolescenti con epilessia incontrano nell'accesso e nella piena partecipazione alla scuola pubblica, rafforzando formazione, informazione e procedure condivise.

Le criticità da superare

- Conoscenze non omogenee sull'epilessia tra il personale scolastico.
- Timore di assumere responsabilità in caso di crisi.
- Difficoltà nella gestione e, quando prevista, nella somministrazione della terapia di emergenza.
- Informazioni cliniche talvolta incomplete, non aggiornate o non facilmente traducibili in istruzioni operative.
- Stigma e sovraprotezione, che possono limitare autonomia, attività e socialità.

02 · UN MODELLO OPERATIVO

Quattro attori, un'unica responsabilità condivisa

La gestione scolastica dell'epilessia funziona quando ciascun soggetto conosce il proprio ruolo. Non serve medicalizzare la scuola: serve costruire una catena semplice di responsabilità, con procedure scritte e comprensibili.

SCUOLA Conosce il piano individuale, forma il personale, garantisce accesso alle attività e applica il protocollo in caso di crisi.	FAMIGLIA Condivide informazioni aggiornate, recapiti, indicazioni cliniche e autorizzazioni necessarie, evitando comunicazioni frammentarie.
SERVIZI SANITARI Definiscono indicazioni cliniche chiare, criteri per l'eventuale terapia di emergenza e modalità di follow-up.	ISTITUZIONI Stabiliscono standard minimi, materiali formativi, responsabilità e strumenti di monitoraggio uniformi.

Il principio guida è la proporzionalità: le misure devono essere calibrate sul profilo clinico dello studente, evitando sia la sottovalutazione del rischio sia restrizioni generalizzate non necessarie.

03 · IL PROTOCOLLO

Un Piano Scuola-Epilessia individuale e leggibile

Ogni studente che ne abbia necessità dovrebbe poter disporre di un documento sintetico, aggiornato e condiviso che traduca le indicazioni cliniche in istruzioni operative per la scuola. Non una cartella sanitaria parallela, ma uno strumento essenziale di sicurezza e inclusione.

Contenuti minimi

- tipologia abituale delle crisi e segnali utili al riconoscimento;
- azioni da compiere e comportamenti da evitare durante una crisi;
- soglia temporale o clinica oltre la quale attivare il 112/118 secondo le indicazioni del curante;
- eventuale farmaco di emergenza: quando utilizzarlo, dove conservarlo e chi è formato alla somministrazione;
- contatti della famiglia e dei riferimenti sanitari indicati;
- indicazioni per educazione fisica, uscite, viaggi di istruzione e altre attività;
- data di revisione del piano e modalità di aggiornamento.

Obiettivo

Ridurre l'improvvisazione. La qualità del sistema non si misura dalla quantità di documenti prodotti, ma dalla capacità di far sì che, nel momento critico, ogni adulto sappia cosa fare in pochi secondi.

04 • FORMAZIONE E CULTURA

Formare senza trasformare gli insegnanti in sanitari

La formazione richiesta alla scuola deve essere pratica, breve, ripetibile e centrata sulle situazioni reali. Il personale non deve sostituire i professionisti sanitari; deve saper riconoscere una crisi, proteggere la persona, attivare i soccorsi quando necessario e seguire le istruzioni definite nel piano individuale.

Un modulo nazionale minimo

- che cos'è l'epilessia e quali forme può assumere;
- cosa fare e cosa non fare durante una crisi;
- quando chiamare i soccorsi;
- gestione dell'eventuale terapia di emergenza secondo procedure autorizzate;
- privacy, comunicazione con i compagni e contrasto allo stigma;
- inclusione nelle attività sportive, ricreative e nelle uscite scolastiche.

La formazione dovrebbe essere disponibile in formato digitale nazionale, con aggiornamenti periodici e materiali semplici per dirigenti, docenti, personale ATA e famiglie. Dove il caso clinico lo richieda, al modulo generale va affiancato un briefing specifico sul singolo studente.

Lo stigma è un rischio di sistema

L'esclusione può assumere forme indirette: rinuncia alle gite, limitazione dell'attività fisica, sorveglianza eccessiva, isolamento o aspettative ridotte. Informazione corretta e protocolli chiari sono strumenti di sicurezza, ma anche di libertà.

05 · RACCOMANDAZIONI

Sette azioni di policy immediatamente attivabili

- 1 Definire linee operative nazionali per la gestione dell'epilessia a scuola, con standard minimi comuni.
- 2 Adottare un modello nazionale di Piano Scuola-Epilessia individuale, semplice e aggiornabile.
- 3 Rendere disponibile un modulo formativo digitale gratuito e periodicamente aggiornato per il personale scolastico.
- 4 Chiarire procedure e responsabilità per l'eventuale somministrazione dei farmaci di emergenza, riducendo l'attuale incertezza applicativa.
- 5 Prevedere un raccordo strutturato tra scuola, famiglia, pediatra/neurologo e servizi territoriali nei casi che lo richiedono.
- 6 Inserire indicatori di inclusione scolastica nei sistemi di monitoraggio, includendo assenze evitabili, partecipazione a gite e attività e segnalazioni di esclusione.
- 7 Promuovere campagne informative rivolte a studenti e famiglie per ridurre stigma e falsi miti sull'epilessia.

06 • ROADMAP

Dalla conferenza a un modello nazionale

La questione non richiede un nuovo livello di burocrazia, ma un coordinamento capace di trasformare pratiche già esistenti in un sistema uniforme. La Fondazione propone una roadmap in tre fasi.

FASE 1 • 0-6 MESI

Tavolo tecnico con Ministeri competenti, Regioni, società scientifiche, rappresentanze scolastiche, famiglie e associazioni. Definizione del modello di Piano Scuola-Epilessia e del curriculum formativo minimo.

FASE 2 • 6-12 MESI

Sperimentazione in un gruppo di istituti e territori, con raccolta di feedback su comprensibilità, tempi di attuazione, responsabilità e gestione della terapia di emergenza.

FASE 3 • 12-24 MESI

Adozione e diffusione nazionale, formazione online, aggiornamento annuale dei materiali e monitoraggio degli indicatori di inclusione.

Indicatore di successo

Il risultato atteso non è soltanto una migliore gestione delle crisi. È la possibilità, per ogni studente con epilessia, di frequentare la scuola, partecipare alle attività e costruire relazioni senza che la propria condizione determini automaticamente esclusione o rinuncia.

CONCLUSIONI

La sicurezza non deve diventare esclusione

L'epilessia a scuola è un banco di prova della capacità delle politiche pubbliche di integrare salute, istruzione e diritti. Quando mancano regole chiare, il sistema trasferisce l'incertezza sulle famiglie, sugli insegnanti e soprattutto sugli studenti. Quando invece esistono formazione, informazioni aggiornate e procedure condivise, la scuola può svolgere pienamente la propria funzione inclusiva.

Il confronto istituzionale avviato in Lombardia ha mostrato che esiste una convergenza concreta sulla necessità di intervenire. Il passo successivo è trasformare questa convergenza in standard operativi nazionali, misurabili e sostenibili.

Messaggio finale

Un bambino o un adolescente con epilessia non deve essere considerato “un problema da gestire”, ma uno studente da mettere nelle condizioni di partecipare pienamente. La buona policy comincia da qui.

Fondazione Boscacci ETS

www.boscacci.it • info@boscacci.it